FLUXOGRAMAS RÁPIDOS:

Itinerário da pessoa com tuberculose no DF

Elaborado por

Gerência de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis

Brasília, 2026

Secretaria de Saúde GDF | FIOCRUZ Brasília | SUS 35 ANOS | MINISTÉRIO DA SAÚDE | GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Governo do Distrito Federal - GDF
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF

ELABORAÇÃO TÉCNICA

Gerência de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis – GEVIST
Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVEP
Subsecretaria de Vigilância à Saúde – SVS
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF
Governo do Distrito Federal – GDF

COLABORADORES

Beatriz Maciel Luz – (GEVIST/DIVEP/SVS/SEAS/SES-DF)
Caio Felipe de Souza – (NEVS/FIOCRUZ)
Claudio Maierovitch Pessanha Henriques – (NEVS/FIOCRUZ)
Júlia Raquel Barbosa dos Santos Costa – (NEVS/FIOCRUZ)
Leonardo da Costa Mota Souza – (GEVIST/DIVEP/SVS/SEAS/SES-DF)
Paulo Biancardi Coury – (NEVS/FIOCRUZ)
Rachel Viana Meneses Taketomi – (NEVS/FIOCRUZ)
Ricardo Gadelha de Abreu – (GEVIST/DIVEP/SVS/SEAS/SES-DF)
Samara Rachel Vieira Nitão – (NEVS/FIOCRUZ)
Stefano Barbosa Codenotti – (NEVS/FIOCRUZ)
Vania Camargo da Costa – (NEVS/FIOCRUZ)

FLUXOGRAMAS RÁPIDOS:
Itinerário da pessoa com tuberculose no DF

Acesse a página da Secretaria:

Brasília – DF
2026

APRESENTAÇÃO

A tuberculose permanece como um importante problema de saúde pública, demandando respostas oportunas e integradas por parte do sistema de saúde. No Distrito Federal, o enfrentamento da doença requer o monitoramento sistemático dos indicadores epidemiológicos, bem como a organização dos fluxos assistenciais, de modo a assegurar o cuidado integral, oportuno e contínuo às pessoas acometidas pela doença.

Neste contexto, este documento foi elaborado com o objetivo de apoiar profissionais e gestores da rede de atenção à saúde (RAS) na compreensão e operacionalização dos percursos assistenciais relacionados à prevenção, diagnóstico, tratamento, acompanhamento e vigilância da tuberculose. Os fluxogramas aqui apresentados buscam demonstrar, de forma objetiva, os processos de trabalho, as responsabilidades dos diferentes pontos de atenção da rede.

O material foi desenvolvido pela Gerência de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, como instrumento técnico-operacional que fará parte da Linha de Cuidado da pessoa com tuberculose, realizado em colaboração com outros setores da SES-DF e fundamentado nas normativas vigentes e nas diretrizes nacionais para o controle da tuberculose, considerando as especificidades organizacionais do Distrito Federal. Ao sistematizar os fluxos, pretende-se contribuir para a qualificação das ações, a redução de falhas no cuidado, o fortalecimento da vigilância e a promoção da integralidade da atenção.

ABREVIATURAS

ACCR	Acolhimento com Classificação de Risco
ACS	Agente Comunitário de Saúde
AAE	Atenção Ambulatorial Especializada
APS	Atenção Primária à Saúde
BAAR	Bacilo Álcool Ácido Resistente
BCG	Bacilo de Calmette e Guérin
CEDIN	Centro Especializado em Doenças Infecciosas
CERA	Central de Regulação Ambulatorial
CERIH	Central de Regulação Hospitalar
CMTB	Complexo *Mycobacterium tuberculosis*
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CRAS	Centro de Referência de Assistência Social
CREAS	Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CRDF	Complexo Regulador do Distrito Federal
E	Etambutol
eAPP	Equipe Atenção Primária Prisional
eMulti	Equipes multiprofissionais na APS
eSF	Equipe de Saúde da Família
ESF	Estratégia Saúde da Família
FUNAI	Fundação Nacional do Índio
GAL	Gerenciador de Ambiente Laboratorial
GEVIST	Gerência de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis
GIR	Gerência de Internação e Regulação
H	Isoniazida
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
HRAN	Hospital Regional da Asa Norte
HRG	Hospital Regional do Gama
IGRA	*Interferon Gamma Release Assay* (Teste de liberação de Interferon Gama)
ILTB	Infecção Latente da Tuberculose
IL-TB	Sistema de Informação para Notificação das Pessoas em Tratamento de ILTB
LACEN-DF	Laboratório Central do Distrito Federal
MNT	Micobactérias não tuberculosas
MS	Ministério da Saúde
NGINT	Núcleo de Gestão de Internação
NVEPI	Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização
OSC	Organizações da Sociedade Civil
PPD	Derivado Proteico Purificado
PPL	Pessoas Privadas de Liberdade
PS	Pronto Socorro
PSR	Pessoa em Situação de Rua
PT	Prova Tuberculínica
PTS	Projeto Terapêutico Singular
PVHA	Pessoa(s) vivendo com HIV ou aids
R	Rifampicina
RAS	Redes de Atenção à Saúde
RX	Raio-X
SAE	Serviço de Atenção Especializada
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SES-DF	Secretaria de Saúde do Distrito Federal
SIM	Sistema de Informações sobre Mortalidade
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SISLEITOS	Sistema de Regulação de Leitos
SISREGIII	Sistema de Regulação
SITE-TB	Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose
SR	Sintomático Respiratório
SUS	Sistema Único de Saúde
TARV	Terapia antirretroviral
TB	Tuberculose
TB-DR	Tuberculose Drogarresistente
TB-MDR	Tuberculose Multidrogaresistente
TB-XDR	Tuberculose Extensivamente Resistente
TDO	Tratamento Diretamente Observado
TRM-TB	Teste Rápido Molecular de Tuberculose
TS	Teste de Sensibilidade
TPT	Tratamento Preventivo da Tuberculose
UBS	Unidade Básica de Saúde
UF	Unidades da Federação
UPA	Unidade de Pronto Atendimento
UTPN	Unidade de Tisiologia e Pneumologia
VE	Vigilância Epidemiológica
Z	Pirazinamida

Sumário

APRESENTAÇÃO 3

ABREVIATURAS 4

RASTREAMENTO DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS 6

FLUXOGRAMA PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE EM ADOLESCENTES E ADULTOS 7

FLUXOGRAMA PARA DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE EM CRIANÇAS COM EXAMES LABORATORIAIS NEGATIVOS 8

SISTEMA DE ESCORE BRASILEIRO 9

FLUXOGRAMA PARA INVESTIGAÇÃO DE CONTATOS DE PESSOAS COM TUBERCULOSE 10

FLUXOGRAMA DE MANEJO DE BACILOSCOPIA POSITIVA APÓS SEGUNDO MÊS DE TRATAMENTO 11

FLUXOGRAMA DE MANEJO DA PESSOA COM TUBERCULOSE NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 12

FLUXOGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE ESQUEMAS ESPECIAIS PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PARA PESSOAS INTERNADAS 13

FLUXOGRAMA PARA TRANSFERÊNCIA E CONTINUIDADE DO CUIDADO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 14

FLUXOGRAMA PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE COM TESTE RÁPIDO MOLECULAR (TRM-TB) 15

FLUXOGRAMA PARA SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA DE CONTROLE MENSAL 16

FLUXOGRAMA DE SOLICITAÇÃO E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 17

FLUXOGRAMA DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS DO TESTE RÁPIDO MOLECULAR E BACILOSCOPIAS NA SES-DF 17

FLUXOGRAMA PARA INVESTIGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO HIV EM PESSOAS COM TUBERCULOSE 18

FLUXOGRAMA PARA RASTREIO DE TUBERCULOSE EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS POR MEIO DO LF-LAM 19

ESQUEMA BÁSICO EM ADULTOS E ADOLESCENTES MAIORES DE 10 ANOS 20

ESQUEMA BÁSICO EM CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS 22

RASTREAMENTO DE **SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS**

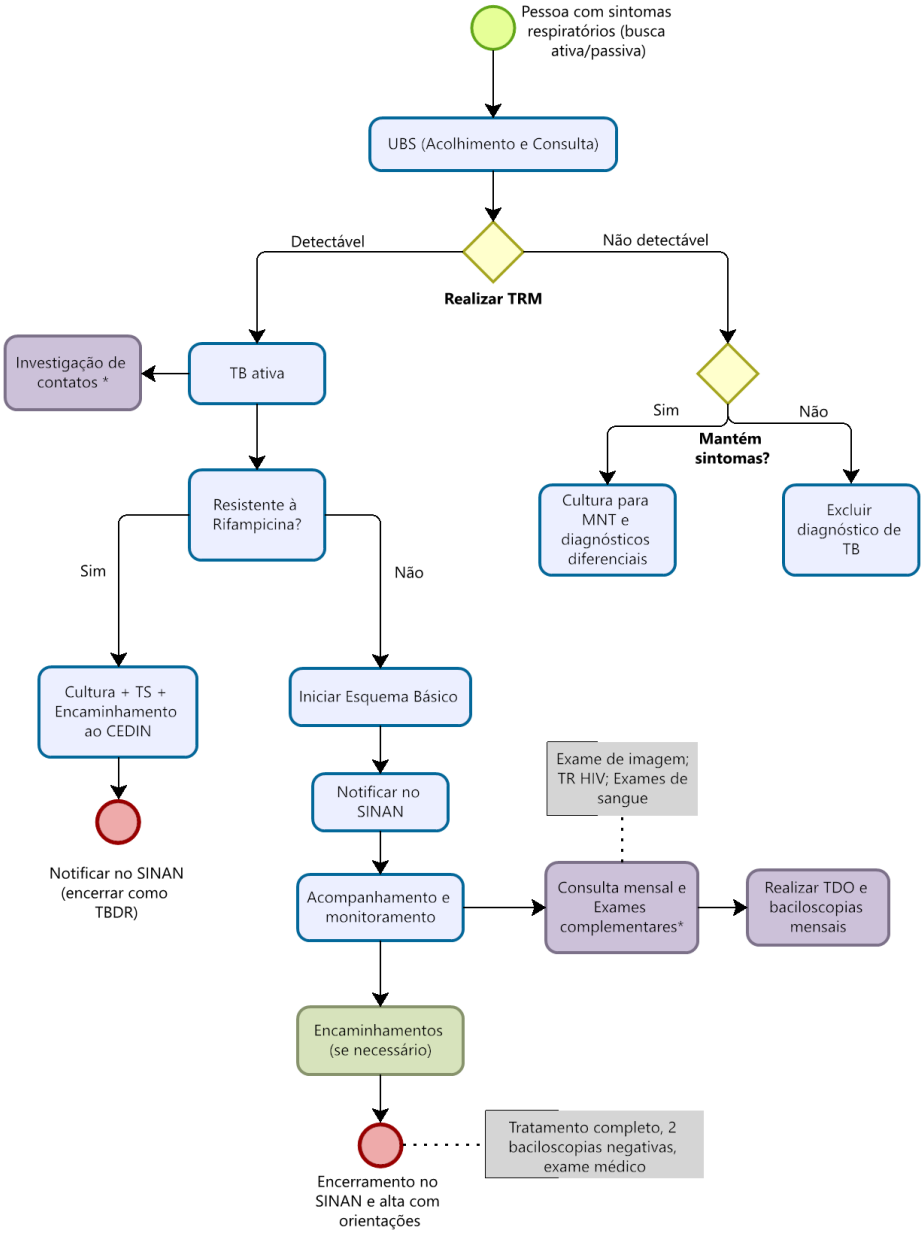
O rastreamento de sintomáticos respiratórios (SR) é uma atividade de saúde pública que visa a identificação precoce de casos para interromper a cadeia de transmissão. Operacionalmente, as equipes devem planejar suas ações para investigar o equivalente a 1% da população total do território ao ano.

Critérios de rastreamento por população:

População / Grupo	Critério (Duração da Tosse)	Periodicidade da Busca	Exames Recomendados
População Geral (busca ativa)	**3 semanas** ou mais	Em todas as visitas do ACS ou ações no território	TRM-TB *(preferencial)* ou Baciloscopia
Contatos de TB Pulmonar	**Qualquer duração**	No momento da identificação do caso índice	TRM-TB + Raio-X de tórax
Pessoas Vivendo com HIV (PVHA)	**Qualquer duração** (avaliar febre, perda de peso ou sudorese)	Em todas as consultas ou visitas ao serviço de saúde	TRM-TB + Cultura + Raio-X
Privados de Liberdade (PPL)	**Qualquer duração**	No ingresso na unidade, contatos e em massa (2x ao ano)	TRM-TB + Cultura + Raio-X
População em Situação de Rua (PSR)	**Qualquer duração**	Em todas as oportunidades de contato com a equipe de saúde	TRM-TB + Cultura+ Raio-X (se possível)
Indígenas	**Qualquer duração**	Em todos os contatos com profissionais ou visitas do AIS	TRM-TB + Cultura
Profissionais de Saúde	**Qualquer duração**	Na admissão e no exame médico anual	TRM-TB + Cultura + Raio-X
Diabetes Mellitus	**2 semanas** ou mais	Em todas as visitas ao serviço de saúde	TRM-TB ou Baciloscopia + Raio-X
População Geral (busca passiva)	**2 semanas** ou mais	No acolhimento e triagem em todas as visitas à UBS, à UPA e ao hospital.	TRM-TB ou Baciloscopia

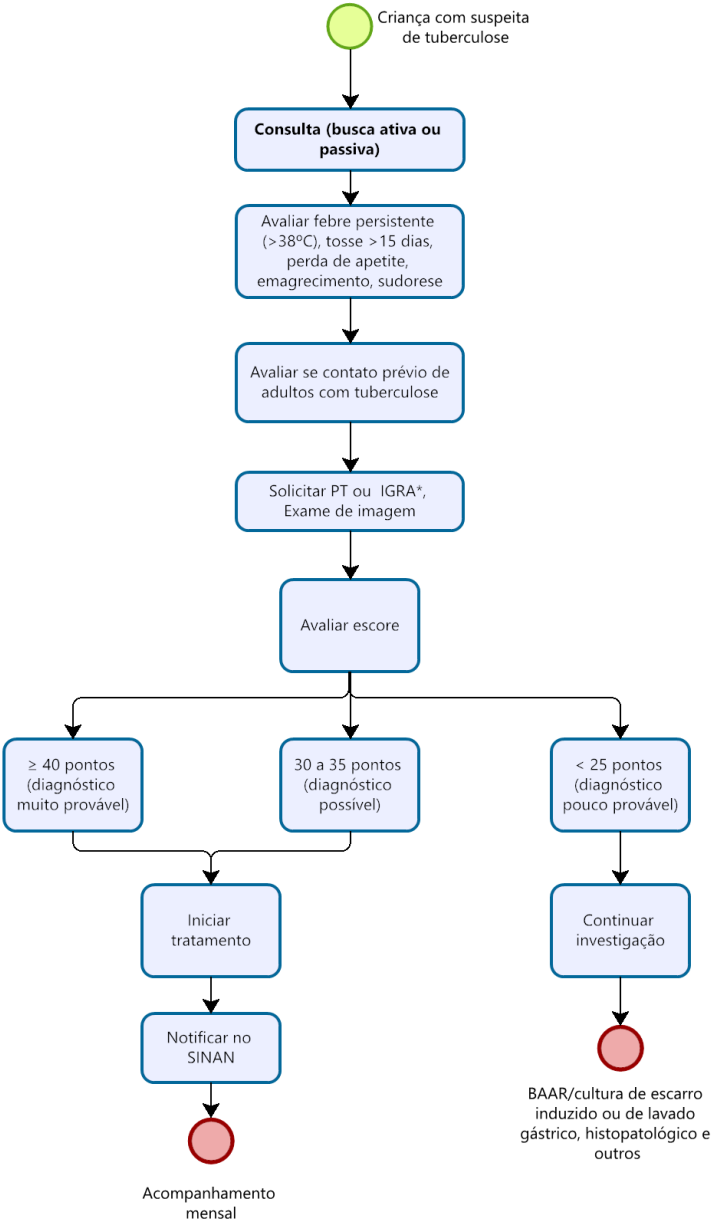
Fonte: Brasil, 2019

FLUXOGRAMA PARA **DIAGNÓSTICO** DE TUBERCULOSE EM **ADOLESCENTES E ADULTOS**



*Olhar o fluxograma para investigação de contatos de pessoas com tuberculose, página 10.

FLUXOGRAMA PARA **DIAGNÓSTICO** DA TUBERCULOSE EM **CRIANÇAS** COM EXAMES LABORATORIAIS NEGATIVOS



*IGRA para crianças ≥ 2 anos e < 10 anos de idade, contato de casos de TB ativa.

SISTEMA DE ESCORE BRASILEIRO

<table>
<tr><th colspan="2">QUADRO CLÍNICO-RADIOLÓGICO</th><th>CONTATOS DE ADULTO COM TB</th><th>PT OU IGRA</th><th>ESTADO NUTRICIONAL</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Febre ou sintomas como tosse, adinamia, expectoração, emagrecimento, sudorese por duas semanas ou mais

15 pontos</td><td rowspan="2">Adenomegalia hilar ou padrão miliar
E/OU

Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) inalterado por duas semanas ou mais

E/OU

Condensação ou infiltrado (com ou sem escavação) por duas semanas ou mais, evoluindo com piora ou sem melhora com antibióticos para germes comuns

15 pontos</td><td rowspan="2">Próximo, nos últimos dois anos

10 pontos</td><td>PT 5 - 9 mm

5 pontos</td><td rowspan="2">Desnutrição grave (peso < percentil 0,1 ou < escore-z -3)

5 pontos</td></tr>
<tr><td>PT ≥10 mm

OU

IGRA reagente/ indeterminado

10 pontos</td></tr>
<tr><td>Assintomático ou com sintomas há menos de duas semanas

0 ponto</td><td>Condensação ou infiltrado de qualquer tipo por menos de duas semanas

5 pontos</td><td rowspan="2">Ocasional ou negativo

0 ponto</td><td rowspan="2">PT <5 mm

0 ponto</td><td rowspan="2">Peso ≥ percentil 0,1 ou ≥ escore-z -3

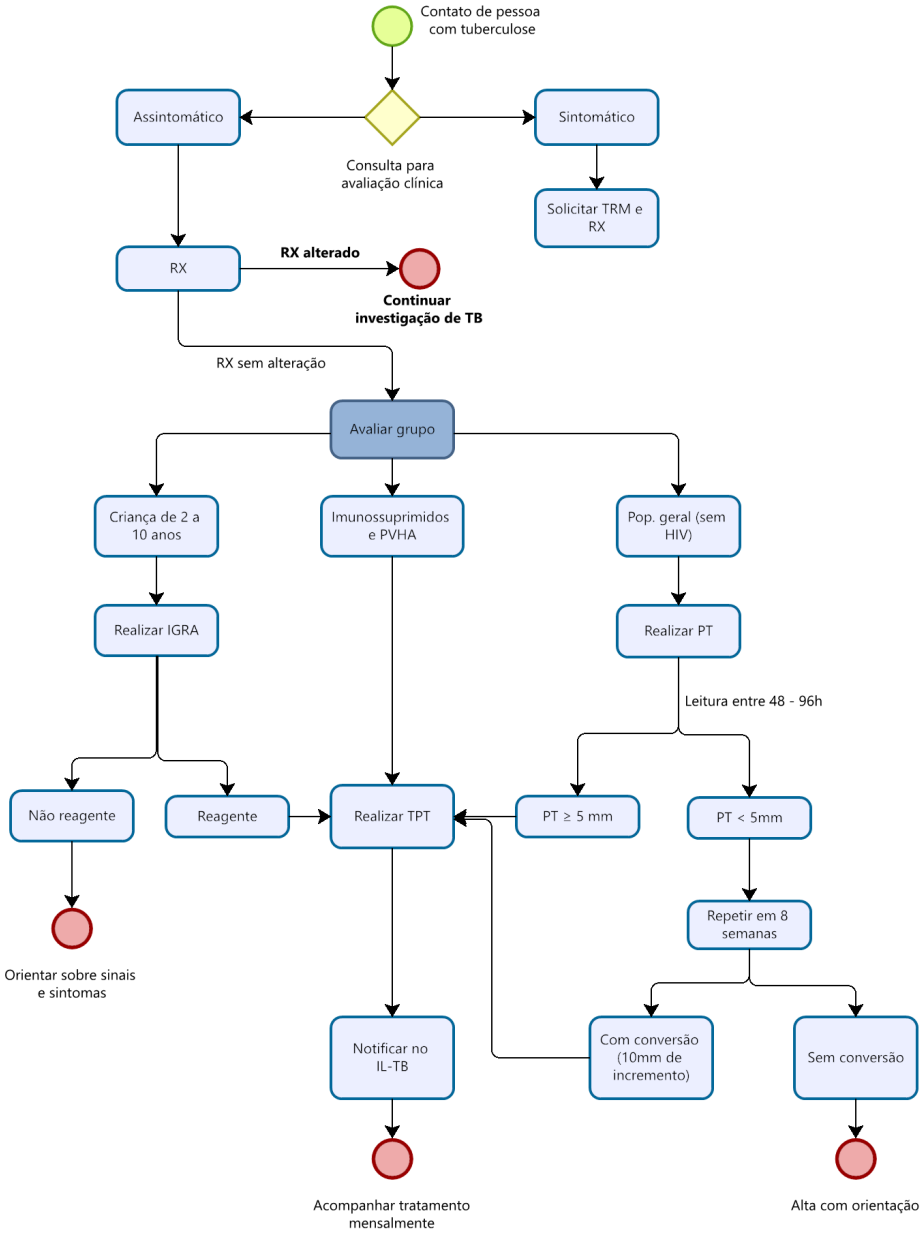
0 ponto</td></tr>
<tr><td>Infecção respiratória com melhora após uso de antibióticos para germes comuns ou sem antibióticos

- 10 pontos</td><td>Radiografia normal

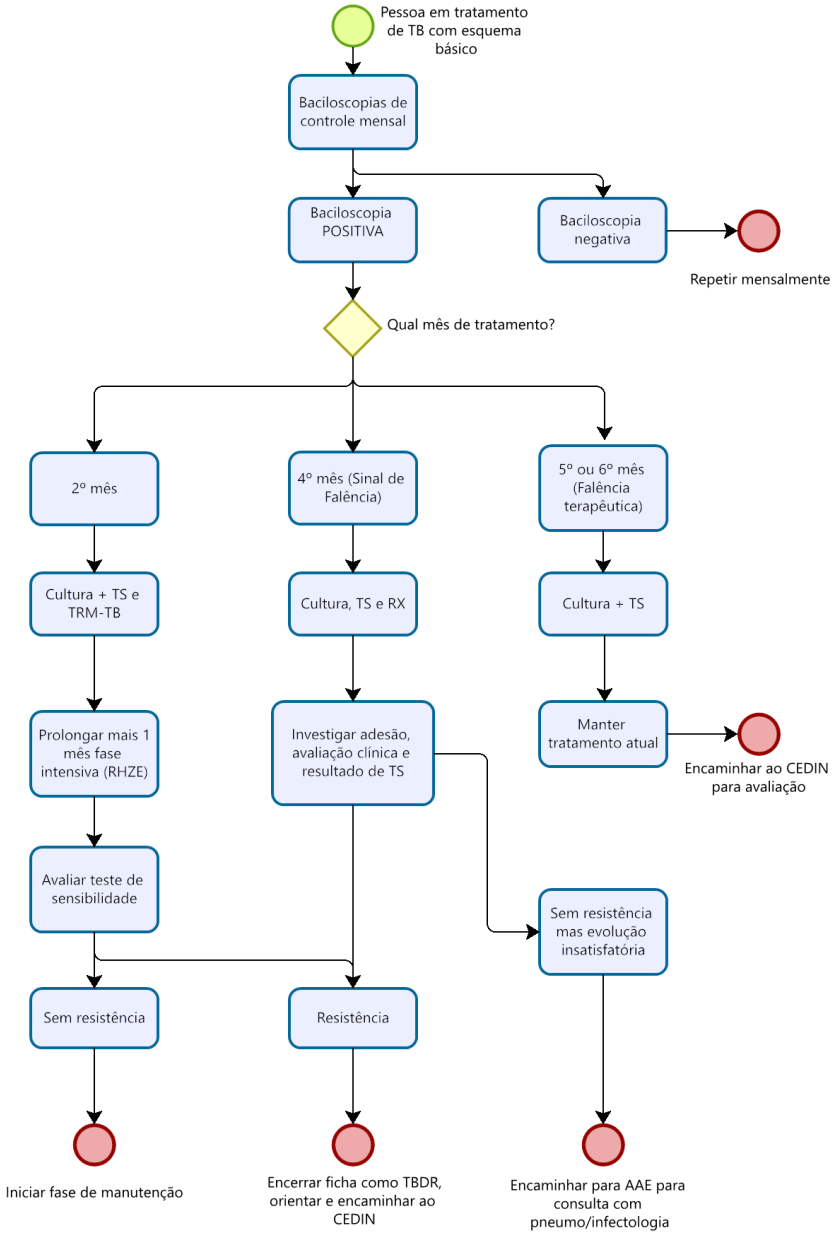
- 5 pontos</td></tr>
<tr><td colspan="5">≥ 40 pontos: Diagnóstico muito provável. Iniciar o tratamento da tuberculose;
30 a 35 pontos: Diagnóstico possível. Indicativo de TB. Iniciar o tratamento a critério médico;
≤ 25 pontos: Diagnóstico pouco provável. Prosseguir com a investigação e realizar diagnóstico diferencial com outras doenças.</td></tr>
</table>

Fonte: Brasil, 2019

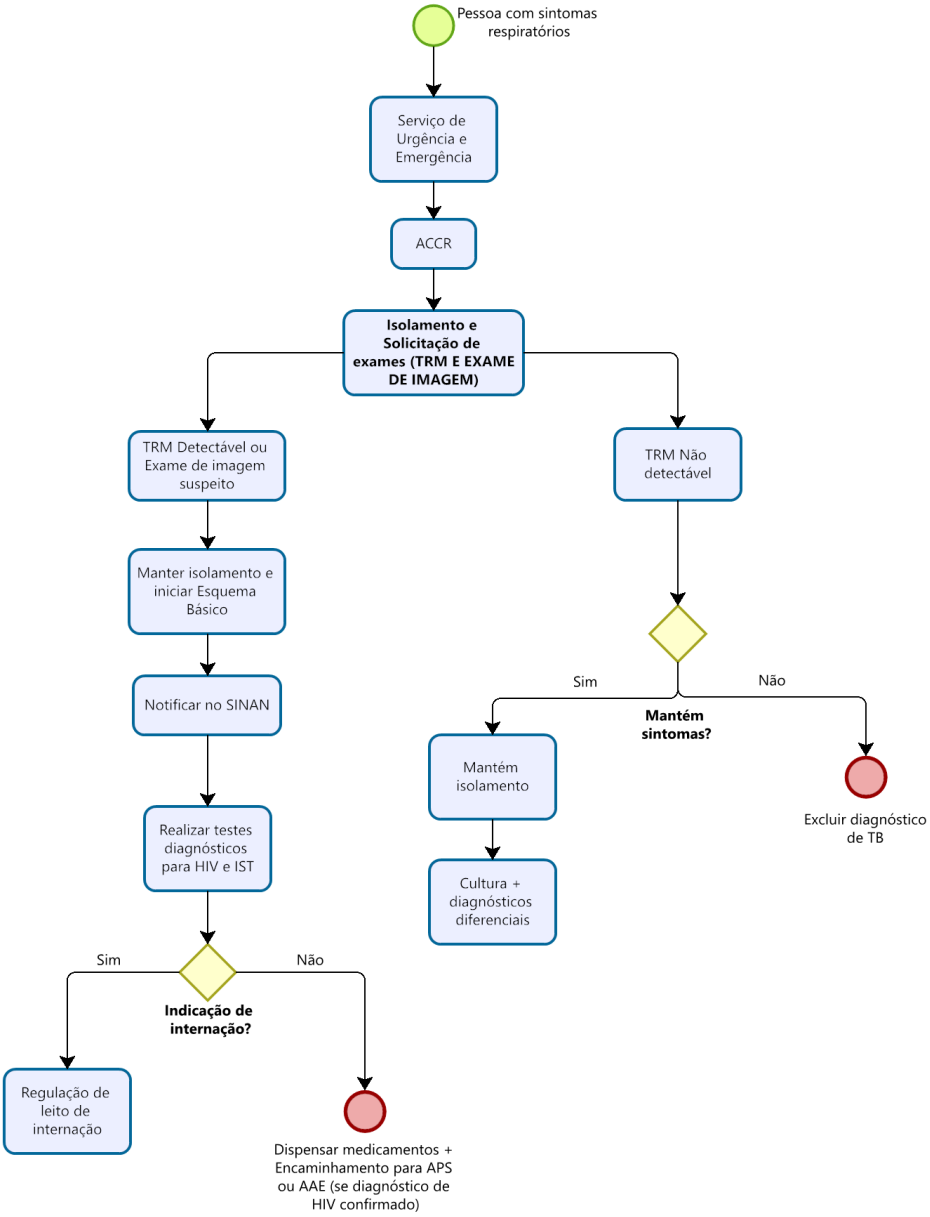
FLUXOGRAMA PARA **INVESTIGAÇÃO DE CONTATOS** DE PESSOAS COM TUBERCULOSE



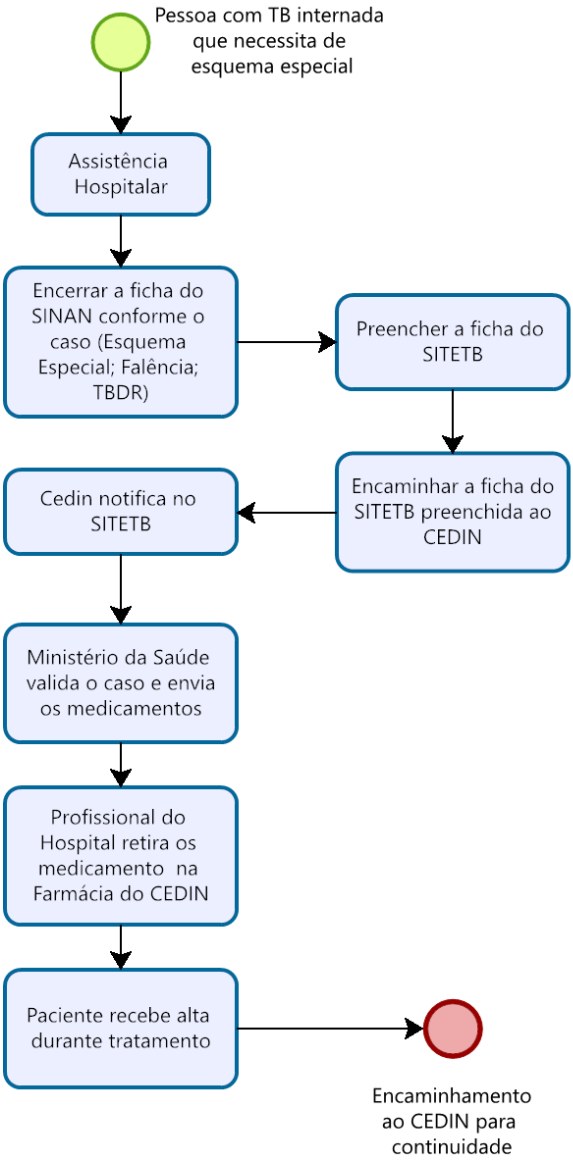
FLUXOGRAMA DE MANEJO DE **BACILOSCOPIA POSITIVA** APÓS SEGUNDO MÊS DE TRATAMENTO



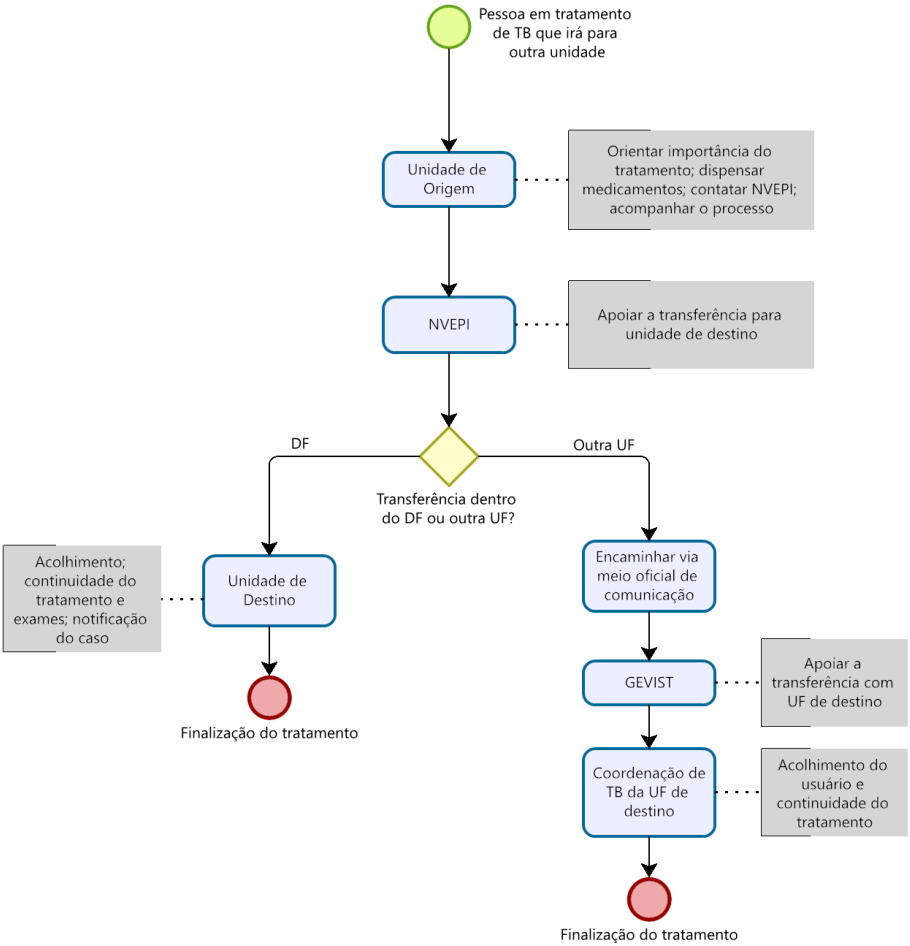
FLUXOGRAMA DE MANEJO DA PESSOA COM **TUBERCULOSE** NOS SERVIÇOS DE **URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**



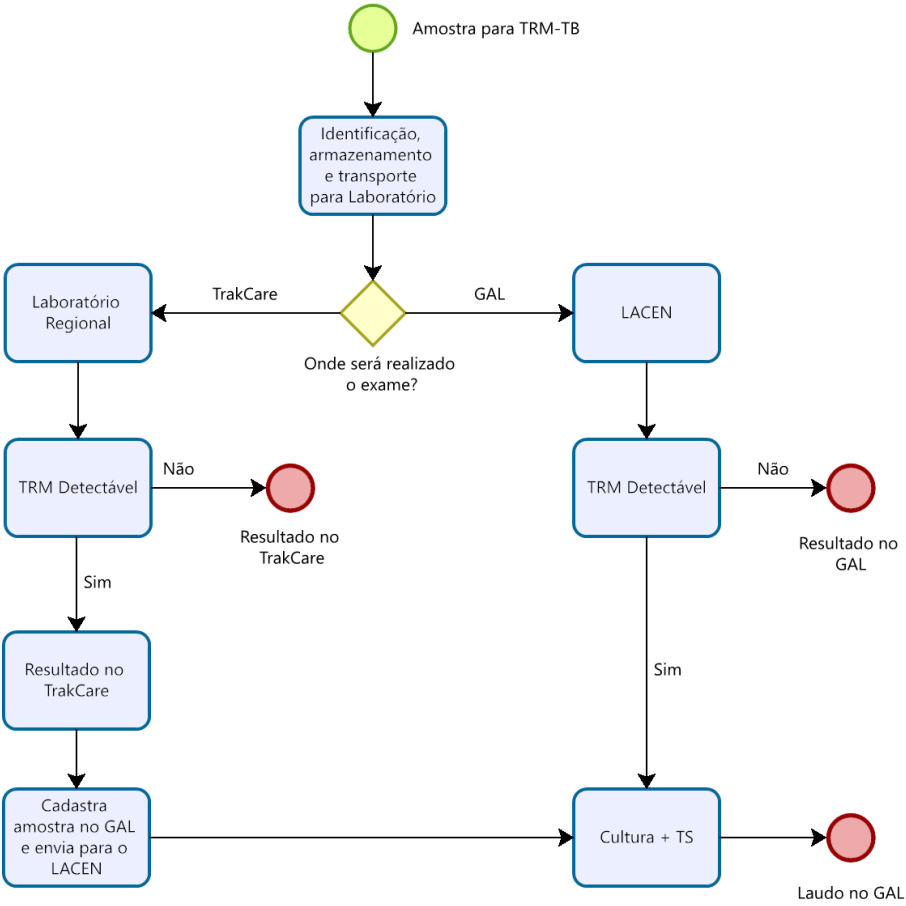
FLUXOGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE **ESQUEMAS ESPECIAIS** PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE PARA **PESSOAS INTERNADAS**



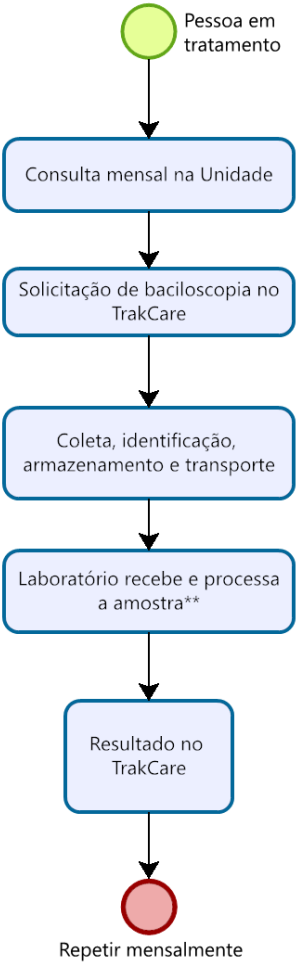
FLUXOGRAMA PARA **TRANSFERÊNCIA** E CONTINUIDADE DO CUIDADO DE **PESSOAS EM TRATAMENTO** DA TUBERCULOSE



FLUXOGRAMA PARA **DIAGNÓSTICO LABORATORIAL** DA TUBERCULOSE COM **TESTE RÁPIDO MOLECULAR** (TRM-TB)



FLUXOGRAMA PARA SOLICITAÇÃO DE **BACILOSCOPIA DE CONTROLE MENSAL**



Obs: TrakCare ou sistema oficial da instituição (Ex: MVSoul)

**FLUXOGRAMA DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS DO TESTE RÁPIDO MOLECULAR E BACILOSCOPIAS NA SES-DF

FLUXOGRAMA DE **SOLICITAÇÃO E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL**

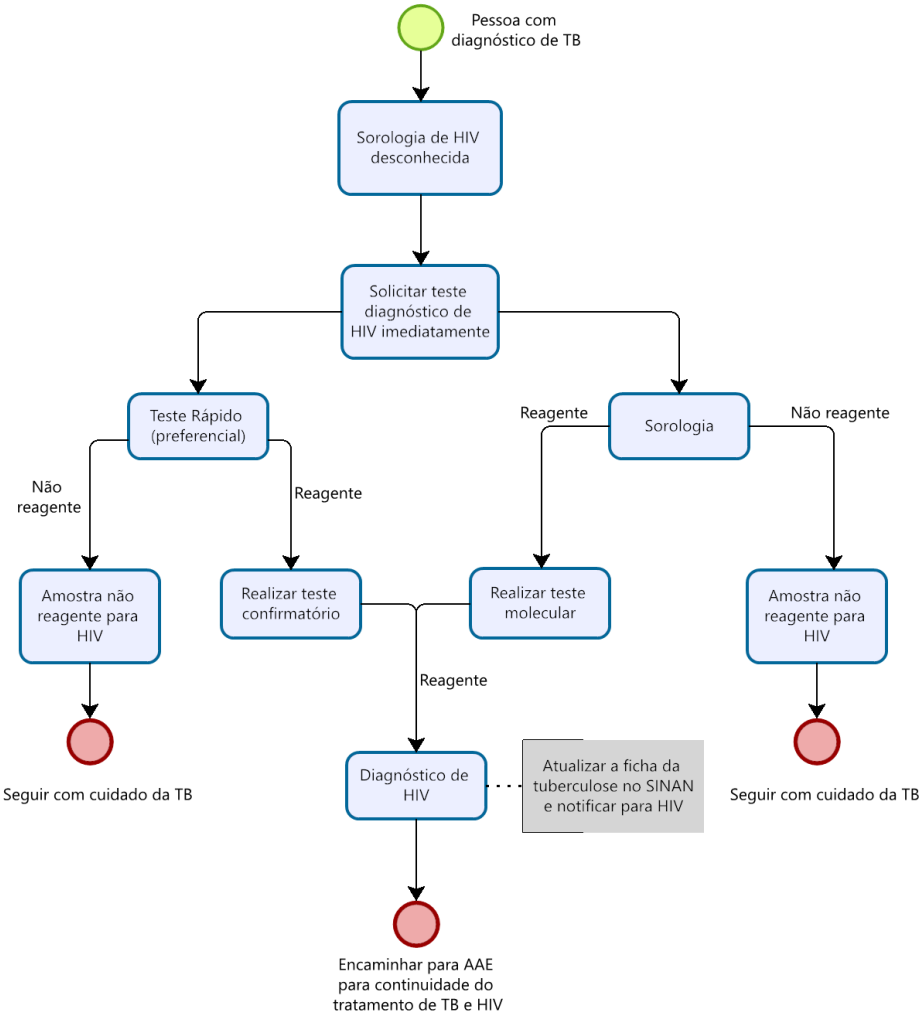
Objetivo do Exame	Situação do Paciente	Exames a solicitar	Amostras de escarro	Quando coletar
Diagnóstico	Casos novos (nunca teve TB)	TRM	1 amostra	No momento da consulta ou visita domiciliar
	Caso novo (criança, extrapulmonar)	TRM + Cultura	1 amostra	
	Casos novos em populações vulneráveis[1]	TRM + Cultura + TS	1 amostra	
Retratamento	Interrupção do tratamento ou recidiva	TRM + BAAR + Cultura	1 amostra	
Controle	Em tratamento (informar mês)	BAAR	1 amostra	No dia da consulta mensal (em casa ou na unidade de saúde)

1- Profissionais de saúde, pessoas vivendo com HIV/aids, população privada de liberdade, população em situação de rua, povos indígenas, contatos de tuberculose resistente.

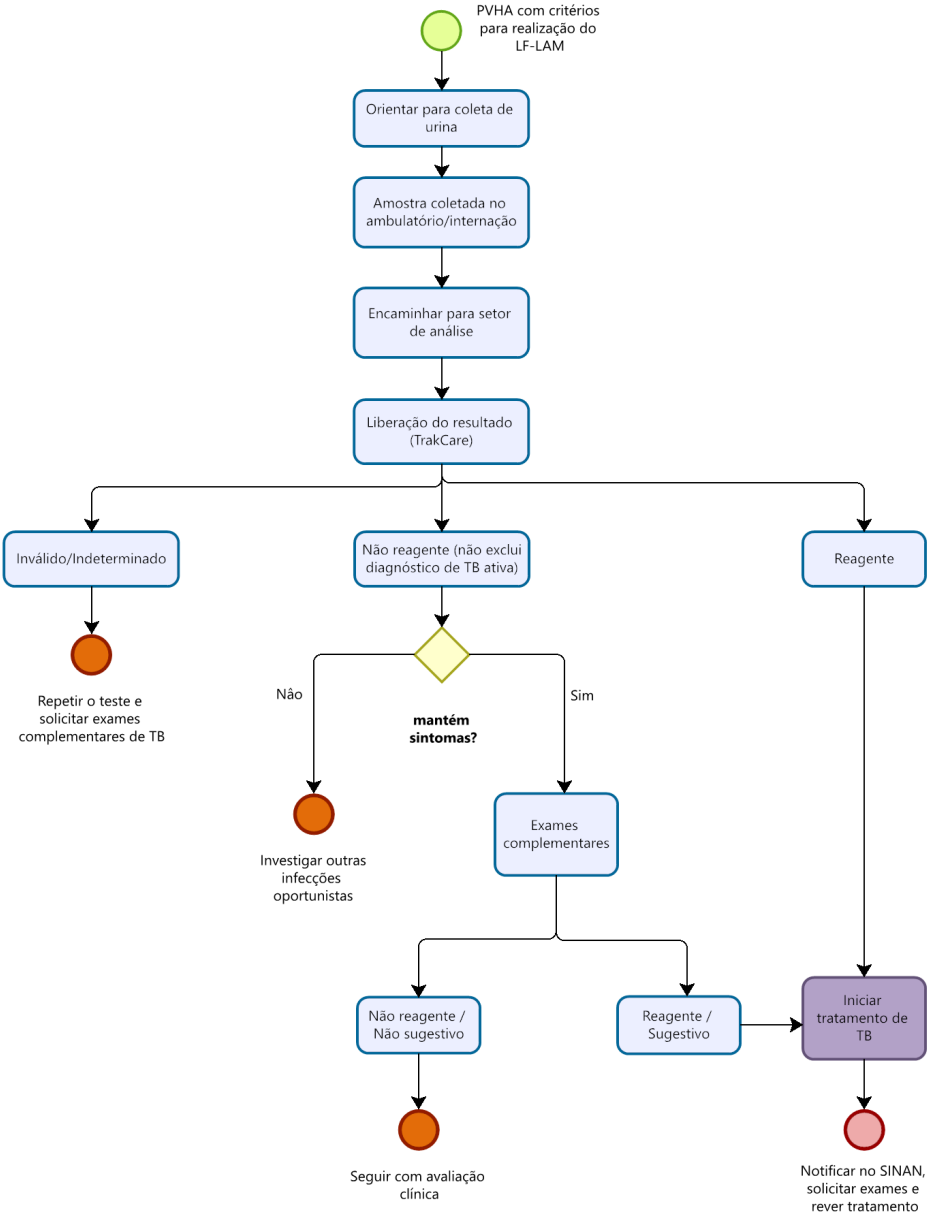
FLUXOGRAMA DE **ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS** DO TESTE RÁPIDO MOLECULAR E BACILOSCOPIAS NA SES-DF

Região	Unidade centralizadora do TRM-TB	Unidade centralizadora da baciloscopia	Fluxo de encaminhamento de amostras
CENTRAL/CENTRO-SUL	HRAN	LRGU, HRGU e HRAN realizarão as baciloscopias das suas unidades	LRGU e HRGU encaminharão as amostras com carro próprio às terças e quintas-feiras ao HRAN
SUDOESTE/OESTE	HRT	LRC	Rota 2 carro do LACEN
NORTE/LESTE	HRL	HRPL e HRS	Rota 3 do LACEN
SUL	HRG	HRG	Fluxo já existente
URD (HMIB, HAB, HCB, HSPV, HAB), CEDIN, IGESDF (HBDF, HRSM, UPA), Hospitais Militares	LACEN	Em cada unidade	Fluxo já existente

FLUXOGRAMA PARA **INVESTIGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO HIV** EM PESSOAS COM TUBERCULOSE



FLUXOGRAMA PARA **RASTREIO DE TUBERCULOSE** EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS POR MEIO DO **LF-LAM**



ESQUEMA BÁSICO EM **ADULTOS E ADOLESCENTES** MAIORES DE 10 ANOS

O Esquema Básico atual para adultos e adolescentes (≥10 anos) é o 2RHZE/4RH, sendo composto por:

Fase	Duração	Droga	Nº de comprimidos por dia			
			20-35 kg	36-50 kg	51-70 kg	>70 kg
1ª	2 meses RHZE	Rifampicina 150 mg Isoniazida 75 mg Pirazinamida 400 mg Etambutol 275 mg	2	3	4	5
2ª	4 meses RH	Meia Dose: Rifampicina 150 mg; Isoniazida 75 mg	2	3	4	5
		Dose Plena: Rifampicina 300 mg; Isoniazida 150 mg	1	1 comp (dose plena) + 1 comp (meia dose)	2 comp	2 comp (dose plena) + 1 comp (meia dose)

Legenda:
RHZE: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)/ Pirazinamida (Z)/ Etambutol (E)
RH: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)
comp - comprimido

Fonte: Brasil, 2019

O Esquema Básico para tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes (≥10 anos) é o 2RHZE/10RH, sendo composto por:

Fase	Duração	Droga	Nº de comprimidos por dia			
			20-35 kg	36-50 kg	51-70 kg	>70 kg
1ª	2 meses RHZE	Rifampicina 150 mg	2	3	4	5
		Isoniazida 75 mg				
		Pirazinamida 400 mg				
		Etambutol 275 mg				
2ª	10 meses RH	Meia Dose: Rifampicina 150 mg; Isoniazida 75 mg	2	3	4	5
		Dose Plena: Rifampicina 300 mg; Isoniazida 150 mg	1	1 comp (dose plena) + 1 comp (meia dose)	2	2 comp (dose plena) + 1 comp (meia dose)
RHZE: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)/ Pirazinamida (Z)/ Etambutol (E) RH: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)						

Fonte: Brasil, 2019

ESQUEMA BÁSICO EM **CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS**

O Esquema Básico para crianças menores de 10 anos é o 2RHZ/4RH, sendo composto por:

Duração	Esquema	Faixas de peso						
		Até 20kg	21-25kg	26-30 kg	31-35 kg	36-39 kg	40-44 kg	>45kg
		Mg/Kg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia
2 meses RHZ	Rifampicina	15(10-20)	300	450	500	600	600	600
	Isoniazida	10 (7-15)	200	300	300	300	300	300
	Pirazinamida	35(30-40)	750	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
4 meses RH	Rifampicina	15(10-20)	300	450	500	600	600	600
	Isoniazida	10(7-15)	200	300	300	300	300	300
RHZ: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)/ Pirazinamida (Z) RH: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)								

Fonte: Brasil, 2019

Para tratamento da TB Meningoencefálica e Osteoarticular, o esquema é 2RHZ/10RH:

Duração	Esquema	Faixas de peso						
		Até 20kg	21-25kg	26-30 kg	31-35 kg	36-39 kg	40-44 kg	>45kg
		Mg/Kg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia	Mg/Dia
2 Meses RHZ	Rifampicina	15(10-20)	300	450	500	600	600	600
	Isoniazida	10 (7-15)	200	300	300	300	300	300
	Pirazinamida	35(30-40)	750	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000
10 meses RH	Rifampicina	15(10-20)	300	450	500	600	600	600
	Isoniazida	10(7-15)	200	300	300	300	300	300
RHZ: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)/ Pirazinamida (Z) RH: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)								

Fonte: Brasil, 2019

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Manual de Recomendações Para o Controle da Tuberculose no Brasil.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019.

Elaboração:

Secretaria de Saúde GDF

Apoio:

FIOCRUZ | Brasília

SUS 35 ANOS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO DO BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO